



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN INFEKSI**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 325.5/I-PDM/DIR/IV/2025

Tentang
Pedoman Kerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Disusun oleh :
Penanggung Jawab PPI



(dr. Aida Musyarofah, Sp. OG)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Kerja Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI) dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Kerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 dengan melalui berbagai review dan update dari beberapa literatur. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada contributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Kerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PEDOMAN KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

1. dr. Nur Mazidah
2. dr. Aida Musyarofah, Sp. OG
3. dr. Ari Putriani, Sp. PK
4. Sherly Rosita, S. Kep, Ns
5. Tri Ani Darma W, A.Md.Kep
6. Veni Lestari Puri P, A.Md.Gz
7. Laras Wieny Nuriska, A.Md.Kep
8. Yuni Novita, A.Md.Kep
9. Raysa Rosadilla, A.Md.Kep
10. Tiara Anggita Putri, S.Tr.Kep., Ns
11. Eko Pambudi, AMd.Kep
12. Rismaya Felantriardianti, S.Kep., Ns
13. Tatik Widayati, S.Kep., Ns
14. Lusianah Nurul I, A.Md.Kep
15. Wahlah, S.Kep., Ns
16. Neni Novitasari, A.Md.Kep
17. Anis Nurlaili, S.Kep., Ns
18. Diyah Purwanti, S.Kep., Ns
19. Resa Novitasari, A.Md.Kep
20. Firda Ayu Maghfiroh, S.Tr.Kep., Ns
21. Purwinda Respati P, A.Md.Kep
22. Trikaya Inggar Yuniar, A.Md.Kep
23. Eko Pambudi, A.Md.Kep
24. Uswatul Chorida, A.Md.Keb
25. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm., Apt
26. Gadis Arivia, S.Farm., Apt
27. Yoga Eka Ramadani Ariwa, A.Md.AK
28. Isma Mufida, A.Md.Rad
29. Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
30. Ahmad Taufan Fauzi, A.Md.Kep
31. Salma Taris Ma'ula
32. Nurmayanti Sekar Wulan, A.Md.RMIK
33. Ayu Lestari Floresa Nur R. A.Md.Aktr
34. Putri Wahyuning Gusti
35. Alifia Ahmad Ageng

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	8
LAMPIRAN.....	1
PEDOMAN KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI	1
BAB I.....	1
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI	1
BAB II.....	3
ORGANISASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI	3
BAB III.....	12
KEGIATAN DAN TATA LAKSANA	12
BAB IV	14
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kedudukan Komite PPI Dalam Struktur Organisasi Fasilitas Kesehatan
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Komite PPI
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Tim PPI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Formulir Elektronik Pelaporan Paparan Infeksius
Lampiran 2	Formulir Supervisi Elektronik
Lampiran 3	Format ICRA Program
Lampiran 4	Formulir Elektronik Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan
Lampiran 5	Formulir Elektronik Audit Bundle HAI's
Lampiran 6	Formulir Elektronik Logbook IPCLN dan Anggota PPI Lainnya
Lampiran 7	Formulir Elektronik Logbook IPCN
Lampiran 8	E-form Monitoring Petugas Isolasi Covid-19
Lampiran 9	E-form Monitoring Magnahelic Tekanan Negatif
Lampiran 10	E-form Monitoring Magnahelic Tekanan Positif
Lampiran 11	Formulir Elektronik Surveilans di SIMRS
Lampiran 12	Formulir Elektronik Pelaporan Phlebitis
Lampiran 13	Formulir Elektronik Pelaporan IDO
Lampiran 14	Formulir Elektronik Pelaporan Decubitus
Lampiran 15	Formulir Elektronik Pelaporan ISK
Lampiran 16	Formulir Elektronik Pelaporan VAP
Lampiran 17	Formulir Elektronik Pelaporan IADP
Lampiran 18	Formulir Elektronik Pelaporan Tumpahan Infeksius
Lampiran 19	Web Komite PPI RS Prima Husada
Lampiran 20	Formulir ICRA Renovasi



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 325.5/I-PDM/DIR/IV/2025**

TENTANG

PEDOMAN KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin pencegahan dan pengendalian di rumah sakit;
b. bahwa agar pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang kebijakan pemberlakuan buku Pedoman Kerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN KERJA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI.**



BAB I

PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Pasal 1

- (1) Komite PPI dibentuk untuk melakukan koordinasi semua kegiatan PPI secara terstruktur yang melibatkan, staf klinis dan non klinis sesuai dengan ukuran, serta kompleksitas Rumah Sakit Prima Husada.
- (2) Segala yang berhubungan dengan rapat Komite PPI diatur oleh sekretaris Komite PPI termasuk persiapan dan hasil rapat.
- (3) Komite PPI membina hubungan kerja dengan Komite/Tim lain di RS yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (4) Rapat rutin Komite PPI dan rapat dengan Komite lainnya dilakukan tiga bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB II

ORGANISASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Pasal 2

Rumah sakit menerapkan mekanisme koordinasi yang melibatkan pimpinan rumah sakit dan Komite PPI untuk melaksanakan program PPI yang meliputi:

- a. Menetapkan definisi infeksi terkait layanan kesehatan.
- b. Metode pengumpulan data (Surveilans).
- c. Membuat strategi/program menangani risiko PPI.
- d. Proses pelaporan.

Pasal 3

Rumah sakit menetapkan IPCN dengan jumlah 100 TT :1 IPCN, dengan kualifikasi pendidikan minimal D-3 keperawatan dan sudah mengikuti pelatihan untuk perawat PPI/PCPN.

Pasal 4

Rumah Sakit menetapkan perawat penghubung /IPCLN dari setiap unit, terutama yang berisiko terjadinya infeksi.

BAB III

KEGIATAN DAN TATA LAKSANA PPI

Pasal 5

Pencegahan dan penanggulangan infeksi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan dalam upaya menurunkan angka kejadian infeksi di rumah sakit.

Pasal 6

Komite PPI melaksanakan kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi dalam upaya mencegah penyebaran infeksi di rumah sakit.



**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 7

Komite PPI melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan PPI di rumah sakit kepada pimpinan rumah sakit.

Pasal 8

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 07 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 325.5/I-PDM/DIR/IV/2025
TENTANG PEDOMAN KERJA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
INFEKSI

PEDOMAN KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

BAB I

PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) difasilitasi pelayanan kesehatan merupakan suatu standar mutu pelayanan dan penting bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung. Pengendalian infeksi harus dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan dan pengunjung dari kejadian infeksi dengan memperhatikan *cost effectiveness*. Pelaksanaan PPI difasilitasi pelayanan kesehatan harus dikelola dan diintegrasikan antara struktural dan fungsional semua departemen / instalasi / divisi / unit difasilitasi pelayanan kesehatan sesuai dengan falsafah dan tujuan PPI.

Pengelolaan pelaksanaan PPI di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Ada kebijakan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk membentuk pengelola kegiatan PPI yang terdiri dari Komite.
2. Pembentukan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan/atau klasifikasi rumah sakit. Contoh untuk RS kelas A dan B struktur organisasinya dalam bentuk Komite PPI, atau RS dengan jumlah tempat tidur lebih dari 100. Untuk RS kelas C dan D diperbolehkan berbentuk Tim PPI, untuk Rumah Sakit Prima Husada menggunakan Komite PPI.
3. Komite bertanggung jawab langsung kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
4. PPI melibatkan komite/departemen / instalasi / unit yang terkait difasilitasi pelayanan kesehatan.
5. Ada kebijakan dan uraian tugas tentang PPI di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pedoman kerja ini memberi panduan bagi tenaga kerja kesehatan di rumah sakit dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi pada pelayanan terhadap pasien yang menderita penyakit menular melalui udara (*airborne*), melalui kontak maupun droplet. Pedoman kerja ini dapat digunakan untuk menghadapi penyakit infeksi lainnya (*emerging infection disease*) yang mungkin akan muncul di masa mendatang baik yang transmisi melalui droplet, *airborne* atau kontak. Ruang lingkup pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi meliputi:

1. Kewaspadaan standart dan berdasarkan transmisi
2. Pelayanan surveilens PPI
3. Hand hygiene
4. Penggunaan APD
5. Pelayanan CSSD/ Sterilisasi
6. Pelayanan Linen
7. Pelayanan kesehatan karyawan
8. Pelayanan Pendidikan dan edukasi staf, pengunjung dan pasien
9. Pelayanan pemeriksaan baku mutu air bersih dan IPAL bekerja sama dengan

sanitasi RS

10. Pelayanan pengolahan kebersihan lingkungan
11. Pelayanan manajemen resiko PPI
12. Antibiotik dan pola kuman RS bekerja sama dengan mikrobiologi dan PPRA
13. Penggunaan bahan single use yang di re-use
14. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja tentang pencegahan dan pengendalian Infeksi
15. Penatalaksanaan KLB
16. Pelayanan Gizi

BAB II

ORGANISASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

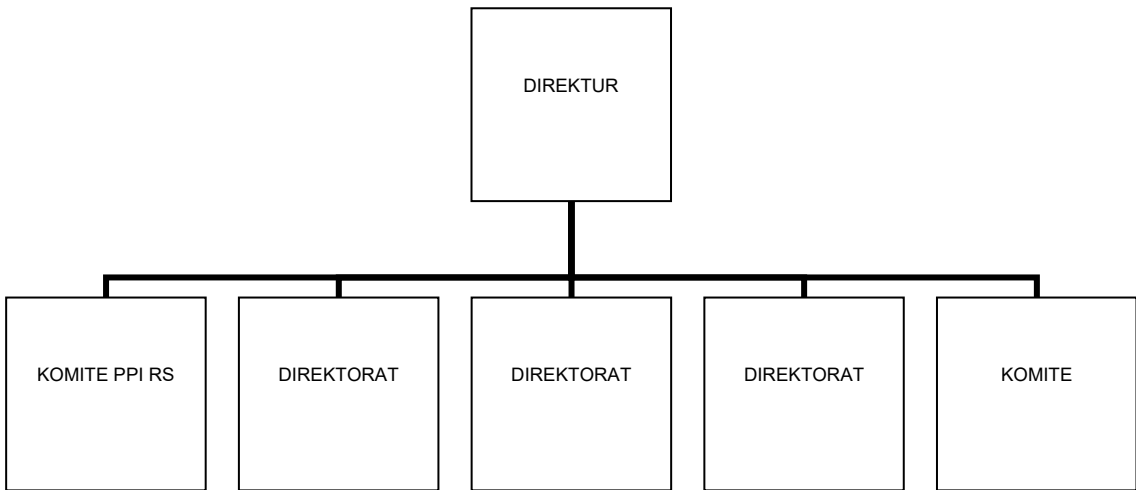
Organisasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) disusun agar dapat mencapai visi, misi dan tujuan dari penyelenggaraan PPI. PPI dibentuk berdasarkan kaidah organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi dan dapat menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Efektif dimaksud agar sumber daya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya nomenklatur organisasi PPI menyesuaikan dengan kondisi SDM dan fasilitas yang dimiliki, namun harus tetap mengikuti kaidah penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Menteri kesehatan.

2.1 STRUKTUR ORGANISASI

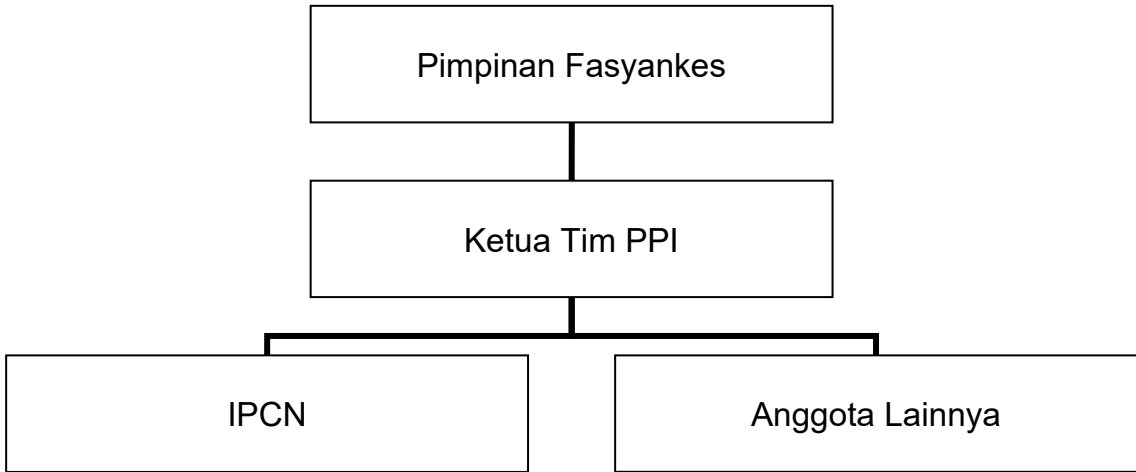
Pimpinan dan petugas kesehatan dalam Komite PPI diberi kewenangan dalam menjalankan program dan menentukan sikap pencegahan dan pengendalian infeksi.

Gambar 2.1 Kedudukan Komite PPI Dalam Struktur Organisasi Fasilitas Kesehatan

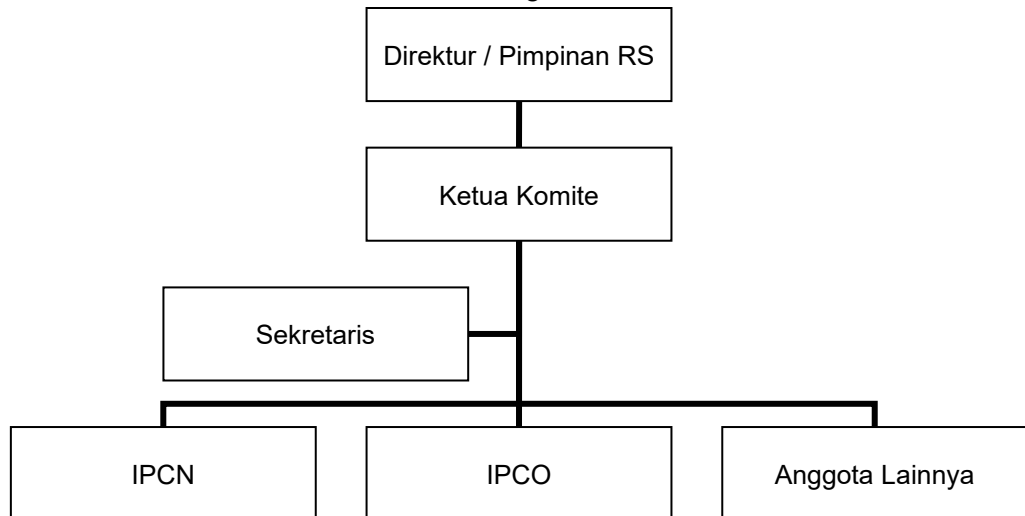


Berdasarkan skema di atas maka kedudukan Komite / Tim PPI harus berada langsung dibawah Pimpinan tertinggi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Komite PPI



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Tim PPI



1. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kriteria :

- Tenaga medis / tenaga kesehatan / tenaga profesional lainnya.
- Memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.
- Memiliki kemampuan leadership.
- Warga Negara Indonesia.
- Bukan pemilik dari rumah sakit tersebut.

Uraian Tugas :

- Menentukan kebijakan pengendalian dan pencegahan infeksi di rumah sakit.
- Membentuk Komite PPIRS dengan Surat Keputusan.
- Mengadakan evaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial berdasarkan saran dari Komite PPIRS.

Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab menyediakan fasilitas, sarana prasarana dan anggaran yang cukup untuk pengendalian infeksi di rumah sakit.
- Bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial.

Wewenang :

- Mengangkat dan memberhentikan ketua Komite PPIRS dengan surat keputusan direktur.
- Dapat menutup suatu unit perawatan atau Unit yang dianggap potensial menularkan penyakit untuk beberapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan saran dari Tim PPIRS.
- Mengesahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk PPIRS.

2. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Tugas:

- Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI.
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPI, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan.
- Membuat SPO PPI.
- Menyusun program PPI dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
- Melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa HAIs (Healthcare Associated Infections).
- Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi.

-
- h. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI.
 - i. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan.
 - j. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit dalam PPI.
 - k. Melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan.
 - l. Berkoordinasi dengan unit terkait lain dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit, antara lain:
 - 1) Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba (TPRA) dalam penggunaan antibiotika yang bijak di rumah sakit berdasarkan pola kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarkan data resistensi antibiotika.
 - 2) Tim kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk menyusun kebijakan.
 - 3) Tim keselamatan pasien dalam menyusun kebijakan *clinical governance* and *patients safety*.
 - m. Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit.
 - n. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI.
 - o. Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi.
 - p. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur / monitoring surveilans proses.
 - q. Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
3. Ketua Komite PPI (IPCO / *Infection Prevention and Control Officer*)
- Kriteria :
- a. Ahli atau dokter yang mempunyai minat dalam PPI.
 - b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PPI.
 - c. Memiliki kemampuan leadership.
- Uraian Tugas :
- a. Berkontribusi dalam diagnosis dan terapi infeksi yang benar.
 - b. Menyusun pedoman surveilans HAIs di Rumah Sakit.
 - c. Mengidentifikasi dan melaporkan kuman patogen dan pola resistensi antibiotika.
 - d. Bekerjasama dengan perawat PPI memonitor kegiatan surveilans infeksi dan mendeteksi serta menyelidiki KLB.
 - e. Membimbing dan mengajarkan praktik dan prosedur PPI yang berhubungan dengan prosedur terapi.
 - f. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien.
 - g. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami pencegahan dan pengendalian infeksi.
- Tanggung Jawab :
- a. Bertanggung jawab atas:
 - 1) Terselenggaranya dan evaluasi program PPI.
 - 2) Penyusunan rencana strategis program PPI.
 - 3) Penyusunan pedoman manajerial dan pedoman PPI.
 - 4) Tersedianya SPO PPI.

- 5) Penyusunan dan penetapan serta mengevaluasi kebijakan PPI.
 - 6) Memberikan kajian KLB infeksi di RS.
 - 7) Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan PPI.
 - 8) Terselenggaranya pengkajian pencegahan dan pengendalian risiko infeksi.
 - 9) Terselenggaranya pengadaan alat dan bahan terkait dengan PPI.
 - 10) Terselenggaranya pertemuan berkala.
- b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program PPI dan program Pendidikan dan pelatihan PPI.
- Wewenang :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan direktur tentang pengendalian infeksi di rumah sakit.

4. Sekretaris Komite PPI (IPCN / *Infection Prevention and Control Nurse*)

Kriteria :

- a. Perawat dengan pendidikan min S1 dan memiliki sertifikasi PPI.
- b. Memiliki komitmen di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi.
- c. Memiliki pengalaman sebagai kepala ruangan atau setara.
- d. Memiliki kemampuan leadership, inovatif, dan confident.
- e. Bekerja penuh waktu.

Uraian Tugas :

- a. Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- b. Memonitor pelaksanaan PPI, penerapan SPO, kewaspadaan isolasi.
- c. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite PPI.
- d. Melakukan investigasi terhadap KLB dan Bersama-sama Komite PPI memperbaiki kesalahan yang terjadi.
- e. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya.
- f. Audit pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk terhadap limbah, laundry, gizi, dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik. Memonitor kesehatan lingkungan .
- g. Memonitor terhadap pengendalian penggunaan antibiotika yang rasional.
- h. Mendesain, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- i. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan PPI.
- j. Mempraktikkan penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang topik infeksi yang sedang berkembang di masyarakat, infeksi dengan insiden tinggi.

Tanggung Jawab :

- a. Bersama Komite PPI melakukan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- b. Bersama Komite menganjurkan prosedur isolasi dan memberikan konsultasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperlukan pada kasus yang terjadi di rumah sakit.
- c. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI.
- d. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI.
- e. Sebagai koordinator antara departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.

Wewenang :

- a. Mengumpulkan data.
- b. Memberikan teguran / peringatan terhadap kesalahan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi.
- c. Membuat laporan surveilans dan melaporkan ke Komite PPI.

5. Anggota Komite PPI

a. IPCD/Dokter PPI :

- 1) Dokter wakil dari tiap KSM (Kelompok Staf Medik).
- 2) Dokter ahli epidemiologi.
- 3) Dokter Mikrobiologi.
- 4) Dokter Patologi Klinik.

Kriteria :

- 1) Dokter yang mempunyai minat dalam PPI.
- 2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PPI.
- 3) Memiliki kemampuan *leadership*.

Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang :

- 1) Berkontribusi dalam pencegahan, diagnosis dan terapi infeksi yang tepat.
- 2) Turut menyusun pedoman penggunaan antibiotika dan surveilans.
- 3) Mengidentifikasi dan melaporkan pola kuman dan pola resistensi antibiotika.
- 4) Bekerjasama dengan IPCN / Perawat PPI melakukan monitoring kegiatan surveilans infeksi dan mendeteksi serta investigasi KLB. Bersama komite PPI memperbaiki kesalahan yang terjadi, membuat laporan tertulis hasil investigasi dan melaporkan kepada pimpinan rumah sakit.
- 5) Membimbing dan mengadakan pelatihan PPI bekerja sama dengan bagian pendidikan dan pelatihan (Diklat) di rumah sakit.
- 6) Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien.
- 7) Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami PPI.

b. IPCN (*Infection Prevention Control Nurse*)

Kriteria:

- 1) Perawat dengan pendidikan minimal Diploma III Keperawatan.
- 2) Mempunyai minat dalam PPI.
- 3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PPI dan IPCN.
- 4) Memiliki pengalaman sebagai Kepala Ruangan atau setara.
- 5) Memiliki kemampuan *leadership* dan inovatif.
- 6) Bekerja penuh waktu.

Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang :

- 1) Melakukan kunjungan kepada pasien yang berisiko di ruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 2) Memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan.
- 3) Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite/Tim PPI.
- 4) Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB.
- 5) Memantau petugas kesehatan yang terpapar bahan infeksius / tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk mencegah penularan infeksi.
- 6) Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di fasyankes.

- 7) Melakukan audit PPI di seluruh wilayah fasyankes dengan menggunakan daftar tilik.
- 8) Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika bersama Komite/Tim PPRA.
- 9) Mendesain, melaksanakan, memonitor mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan bersama Komite / Tim PPI.
- 10) Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI.
- 11) Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI.
- 12) Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI.
- 13) Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga dan pengunjung tentang topik infeksi yang sedang berkembang (New-emerging dan re- emerging) atau infeksi dengan insiden tinggi.
- 14) Sebagai coordinator antar departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi dirumah sakit.
- 15) Memonitoring dan evaluasi peralatan medis *single use* yang di *re – use*.

c. IPCLN (*Infection Control Link Nurse*)

Kriteria :

- 1) Perawat dengan pendidikan min D3 dan memiliki sertifikasi PPI.
- 2) Memiliki komitmen di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi.
- 3) Memiliki kemampuan leadership.

Uraian Tugas :

IPCLN sebagai perawat pelaksana harian/penghubung bertugas:

- 1) Menginput surveilans setiap pasien di unit rawat inap masing-masing kedalam SIMRS.
- 2) Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan pencegahan dan pengendalian infeksi pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing-masing.
- 3) Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya infeksi nosokomial pada pasien.
- 4) Berkoordinasi dengan IPCN saat terjadi infeksi potensial KLB, penyuluhan bagi pengunjung di ruang rawat masing-masing konsultasi prosedur yang harus dijalankan bila belum faham.

Tanggung Jawab :

- 1) Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya infeksi nosocomial pada pasien.

Wewenang :

- 1) Memberikan motivasi dan teguran tentang kepatuhan pelaksanaan PPI pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing – masing
- 2) Memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam menjalankan standar isolasi.

d. Anggota komite lainnya, dari :

- 1) Tim DOTS
- 2) Tim HIV
- 3) Laboratorium.
- 4) Farmasi.
- 5) Sterilisasi
- 6) Laundri
- 7) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS).

- 8) Sanitasi lingkungan
- 9) Pengelola makanan
- 10) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- 11) Kamar jenazah.

Kriteria / kualifikasi:

- 1) Tenaga diluar dokter dan perawat yang mempunyai minat dalam PPI.
- 2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PPI.

Uraian Tugas:

- 1) Menetapkan definisi infeksi terkait layanan kesehatan.
- 2) Membuat strategi / program menangani risiko PPI.
- 3) Proses pelaporan.
- 4) Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPIRS, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan rumah sakit.
- 5) Membuat SPO PPI.
- 6) Melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan.
- 7) Berkoordinasi dengan unit terkait lain.
- 8) Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit.
- 9) Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur/ monitoring surveilans proses.

Tanggung Jawab

- 1) Metode pengumpulan data (surveilans).
- 2) Turut menyusun kebijakan clinical governance dan patient safety.
- 3) Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 4) Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI.

Wewenang

- 1) Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi.
- 2) Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI.
- 3) Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan.
- 4) Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan mana bagi yang menggunakan\Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit dalam PPI.
- 5) Memberikan usulan kepada Direktur untuk pemakaian antibiotika yang rasional di rumah sakit berdasarkan hasil pantauan kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika.
- 6) Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi.

2.2 Sarana dan Fasilitas Pelayanan Penunjang

1. Sarana Kesekretariatan

- a. Ruang sekretariat dan tenaga sekretaris yang penuh waktu.
- b. Komputer, printer dan internet.
- c. Telepon dan Faksimili.

- d. Sarana kesekretariat lainnya.
- 2. Dukungan Manajemen
 - Dukungan yang diberikan oleh manajemen berupa :
 - a. Surat Keputusan untuk Komite / Tim PPI.
 - b. Menyediakan anggaran untuk:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
 - 2) Pengadaan fasilitas pelayanan penunjang.
 - 3) Pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, laporan dan rapat rutin.
 - 4) Remunerasi/ insentif/ Tunjangan/ penghargaan untuk Komite/ Tim PPI.
- 3. Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional
 - Kebijakan yang perlu dipersiapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan adalah:
 - a. Organisasi Komite PPI terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang terdiri dari IPCN, IPCD, dan anggota lainnya.
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki IPCN yang bekerja penuh waktu dengan rasio 1 IPCN untuk setiap 100 tempat tidur pasien.
 - c. Dalam bekerja IPCN dibantu oleh IPCLN dari tiap unit, terutama unit yang berisiko infeksi.
 - d. Kedudukan IPCN secara fungsional berada di bawah Komite PPI dan secara professional berada di bawah keperawatan setara dengan senior manajer.
 - e. Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan PPI sekaligus pengembangan SDM Komite / Tim.
 - f. Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan untuk seluruh petugas di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - g. Kebijakan tentang kewaspadaan isolasi meliputi kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi termasuk kebijakan tentang penempatan pasien.
 - h. Kebijakan tentang PPI pada pemakaian alat kesehatan dan tindakan operasi.
 - i. Kebijakan tentang kesehatan karyawan.
 - j. Kebijakan tentang pelaksanaan surveilans.
 - k. Kebijakan tentang penggunaan antibiotik yang bijak.
 - l. Kebijakan tentang pengadaan bahan dan alat yang melibatkan tim PPI.
 - m. Kebijakan tentang pemeliharaan fisik dan sarana prasarana.
 - n. Kebijakan penanganan kejadian luar biasa.
 - o. Kebijakan tentang pelaksanaan audit PPI.
 - p. Kebijakan tentang pengkajian risiko di fasilitas pelayanan kesehatan.

SPO yang perlu dipersiapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan antara lain:

- a. Kewaspadaan isolasi, :
 - 1) Kebersihan Tangan
 - 2) Alat Pelindung Diri (APD): sarung tangan, masker, kaca mata/pelindung mata, perisai wajah, gaun, apron, sepatu bot/sandal tertutup
 - 3) Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien
 - 4) Pengendalian Lingkungan
 - 5) Penatalaksanaan Limbah
 - 6) Penatalaksanaan Linen
 - 7) Perlindungan Petugas Kesehatan
 - 8) Penempatan Pasien
 - 9) Hygiene Respirasi/Etika Batuk
 - 10) Praktek Menyuntik Yang Aman
 - 11) Praktek Lumbal Pungsi
- b. Upaya pencegahan infeksi sesuai pelayanan di fasilitas pelayanan

kesehatan, yang antara lain :

- 1) Infeksi saluran kemih (ISK).
- 2) Infeksi daerah operasi (IDO).
- 3) Infeksi aliran darah (IAD).
- 4) Pneumonia akibat penggunaan ventilator (VAP).
- 5) Kebijakan tentang PPI lainnya (misalnya Phlebitis dan decubitus).

2.3 Pengembangan dan Pendidikan

1. Komite PPI

- a. Wajib memiliki pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut PPI.
- b. Memiliki sertifikat PPI.
- c. Mengembangkan diri mengikuti seminar, lokakarya, dan sejenisnya.
- d. Bimbingan teknis secara berkesinambungan.

2. Staf Rumah Sakit

- a. Semua staf rumah sakit harus mengetahui prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi.
- b. Semua staf rumah sakit yang berhubungan dengan pelayanan pasien harus mengikuti pelatihan PPI.
- c. Rumah sakit secara berkala melakukan sosialisasi/simulasi PPI.
- d. Semua karyawan baru harus mendapatkan orientasi PPI.

BAB III

KEGIATAN DAN TATA LAKSANA

3.1 Batasan – Batasan

1. *Healthcare Associated Infection (HAIs)* adalah infeksi yang terjadi atau didapat di rumah sakit. Suatu infeksi didapat di rumah sakit apabila:
 - a. Pada saat masuk rumah sakit tidak ada gejala atau tidak merasakan inkubasi infeksi tersebut.
 - b. Inkubasi terjadi 2x24 jam setelah pasien di rawat di rumah sakit.
 - c. Infeksi pada lokasi sama terapi disebabkan oleh mikroorganisme yang berbeda dari mikroorganisme pada saat masuk rumah sakit atau mikroorganisme penyebab sama tetapi lokasi infeksi berbeda.
2. Pencegahan dan penanggulangan infeksi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan dalam upaya menurunkan angka kejadian infeksi nosocomial di rumah sakit.
3. Surveilans adalah kegiatan pengamatan sistematis aktif dan terus menerus terhadap timbulnya dan penyebaran infeksi pada suatu peristiwa yang menyebabkan peningkatan atau penurunan resiko tersebut.
4. Kejadian luar biasa adalah kejadian yang menarik perhatian umum dan mungkin menimbulkan kehebohan/ketakutan dikalangan masyarakat, atau menurut pengamatan epidemiologis dianggap adanya peningkatan yang berarti dari kejadian kesakitan/kematian akibat penyakit tersebut.
5. Suatu kejadian di rumah sakit dapat disebut kejadian Luar Biasa (KLB) bila proportional rate penderita baru dari suatu penyakit menular dalam waktu satu bulan, dibandingkan dengan proportional rate penderita baru dari penyakit menular yang sama selama periode waktu yang sama dari tahun yang lalu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih, atau terdapat satu kejadian pada keadaan dimana sebelumnya tidak pernah ada.

3.2 Pencegahan Standar

Penerapan pencegahan standar untuk mencegah transmisi silang sebelum pasien di diagnosis, sebelum adanya hasil pemeriksaan laboratorium dan setelah pasien didiagnosis. Tenaga kesehatan seperti petugas laboratorium, rumah tangga, CSSD, pembuang sampah dan lainnya juga berisiko besar terinfeksi. Oleh sebab itu penting sekali pemahaman dan kepatuhan petugas tersebut untuk juga menerapkan Kewaspadaan Standar agar tidak terinfeksi. CDC dan HICPAC merekomendasikan 11 (sebelas) komponen utama yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam kewaspadaan standar, yaitu: kebersihan tangan, Alat Pelindung Diri (APD), dekontaminasi peralatan perawatan pasien, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, penatalaksanaan linen, perlindungan kesehatan petugas, penempatan pasien, hygiene respirasi/etika batuk dan bersin, praktik menyuntik yang aman dan praktik lumbal pungsi yang aman.

3.3 Pencegahan Transmisi

Kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai tambahan Kewaspadaan Standar yang dilaksanakan sebelum pasien didiagnosis dan setelah terdiagnosis jenis infeksinya. Jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai berikut:

1. Melalui kontak
2. Melalui droplet
3. Melalui udara (Airborne Precautions)
4. Melalui common vehicle (makanan, air, obat, alat, peralatan)
5. Melalui vektor (lalat, nyamuk, tikus)

Pencegahan tambahan dilaksanakan dalam situasi prosedur pencegahan standar yang tidak cukup untuk mencegah infeksi silang. Pelaksanaan pencegahan ini perlu dipisahkan dari pasien-pasien yang memperoleh fasilitas khusus. Pasien-pasien dengan infeksi serupa dapat dikelompokkan tersendiri dengan jarak minimal bed 1 meter.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring

Monitoring dilakukan oleh seluruh anggota Komite PPI.

4.2 Evaluasi

Rapat evaluasi dilakukan oleh Komite PPI minimal setiap sebulan sekali. Rapat evaluasi dengan Komite Mutu dilakukan minimal 3 bulan sekali.

4.3 Laporan

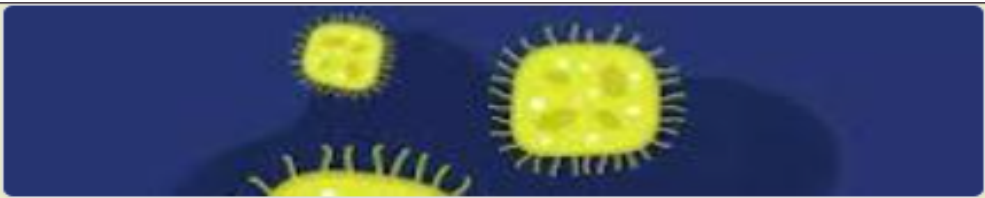
Laporan dari IPCN kepada Ketua Komite PPI setiap bulan, dan laporan Komite PPI 3 bulan sekali yang ditujukan kepada Direktur RS.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 07 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah

Lampiran 1

Formulir Elektronik Pelaporan Pajanan Infeksius



Formulir Laporan Pajanan Infeksius

Formulir ini digunakan untuk merekan kejadian pajanan infeksius yang ada di unit.

kppirsphmalang@gmail.com [Ganti akun](#) 

** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi*

Email ***

☐ Rekam kppirsphmalang@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

Tanggal Lapor ***

Tanggal

dd/mm/yyyy 

Nama Unit ***

(Diisi dengan huruf kapital)

Jawaban Anda

Nama terpajan ***

(Diisi dengan huruf kapital)

Jawaban Anda

Nama pelapor ***

(Diisi dengan huruf kapital)

Jawaban Anda

Route pajanan ***

Pilih 

Sumber pajanan ***

☐ Darah

☐ Sputum

☐ Air liur

☐ Feses

☐ Lain-lain

Kronologi kejadian *

Jawaban Anda

Jenis APD yang digunakan *

Jawaban Anda

Pertolongan pertama *

Jawaban Anda

Diagnosa & Riwayat Pasien *

Jawaban Anda

No RM *

(isi dengan simbol (-) jika sumber pajanan tidak diketahui)

Jawaban Anda

Nama Pasien *

(isi dengan simbol (-) jika sumber pajanan tidak diketahui)

Jawaban Anda

Tindakan terpajan *

Pilih

Sudah dilaporkan ke *

	Ya	Tidak
Komite PPI	☐	☐
SDM	☐	☐
K3RS	☐	☐
Lainnya	☐	☐

Tindakan lanjutan *

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir

Pelaporan Elektronik pada SIMRS

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS)


RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
 Banjararum Selatan No.3 Mondoroko - Malang

Pengendali Mutu <<

Kejadian Kecelakaan Kerja
 Pengendalian Mutu Rekap Data Angka
 Insiden Keselamatan Pasien

Transaksi
 Master
 Laporan
 Grafik
 Insiden/Kecelaka
 IKP
 K3

Pengendali Mutu
 Logistik
 Rekam Medis
 Pelayanan Kesehatan
 Front Office
 Sistem
 Kejadian Kecelakaan Kerja

Kejadian Kecelakaan Kerja

Browse
 Detail

Data Insiden
 ID:
 Tgl. Laporan: 19/07/2025 10:33:32
 Unit Kegiatan:
 Lokasi Kecelakaan:
 Tgl. Kecelakaan: 01/01/2025 10:33:32
 Jml. Korban: 0 orang

Korban
 Analisa Kejadian Kecelakaan
 Rencana Tindak Lanjut
 Catatan

No.	Nama Korban	Jns. Kelamin	Umur	Unit Asal/Jabatan	Kategori Cedera	Anggota Badan yang Cedera	Penanganan	Perkiraan Biaya	Kehilangan Jam Kerja
<No data to display>									

Simpan
 Batal
 Tutup

Aktif
 Sherly Rosita S. Kep. Ns (sherly)
 SIMRS v250618.01 on 172.6.39.97

Pengendali Mutu

- Transaksi
- Master
- Laporan
- Grafik
- Insiden/Kecelaka
- IKP
- K3

Pengendali Mutu

Logistik

Rekam Medis

Pelayanan Kesehatan

Front Office

Sistem

Kejadian Kecelakaan Kerja

Pengendalian Mutu Rekap Data Angka

Insiden Keselamatan Pasien

Kejadian Kecelakaan Kerja
Kejadian Kecelakaan Kerja

Browse Detail

Data Insiden

ID: Tgl. Laporan: 19/07/2025 10:33:32
Unit Kegiatan:
Lokasi Kecelakaan:
Tgl. Kecelakaan: 01/01/2025 10:33:32 Jml. Korban: 0 orang

Korban Analisa Kejadian Kecelakaan Rencana Tindak Lanjut Catatan

Jenis Kecelakaan: Tertusuk Keterangan:
Akibat B3: ☐ Ya Penyebab:
Penyebab:
Kronologis:
Analisa Penyebab:
Saksi/ Pelapor:
Akibat: a. Tenaga Kerja: ☐ Tidak Ada Cedera 0 orang ☐ Cedera Sedang 0 orang ☐ Meninggal 0 orang
☐ Cedera Ringan 0 orang ☐ Cedera Berat 0 orang
b. Kerusakan Aset:
c. Kerusakan Lingkungan:

Simpan

Batal

Tutup

Lampiran 2
Formulir Supervisi Elektronik



01 Formulir Fasilitas Kebersihan Tangan

Formulir yang harus diisi saat melakukan pemantauan fasilitas kebersihan tangan.

kppirsphmalang@gmail.com

Ganti akun



Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini

*** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**

Email *

☐ Rekam kppirsphmalang@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

Tanggal Audit *

Tanggal

dd/mm/yyyy



PW *

Jawaban Anda

Nama Auditor *

☐ Sherly Rosita, S. Kep. Ns

Periode Laporan *

Pilih



Ruangan yang di Audit *

Pilih



Berikutnya

Kosongkan formulir

PENGAMATAN FASILITAS KEBERSIHAN TANGAN

Isilah berdasarkan hasil pengamatan anda.

Fasilitas Kebersihan Tangan: *

8 poin

	Ya	Tidak	Tidak keduanya
Tersedia sabun cair di setiap wastafel.	☐	☐	☐
Tersedia handuk kertas / tissue di setiap wastafel.	☐	☐	☐
Tersedia cairan anti bakterial di wastafel ruang tindakan invasif..	☐	☐	☐
Wastafel bebas dari peralatan yang tidak tepat.	☐	☐	☐
Failitas cuci tangan bersih.	☐	☐	☐
Ada tempat sampah di dekat wastafel.	☐	☐	☐
Tersedia handrub di ruangan dan setiap bed pasien.	☐	☐	☐
Tersedia poster/stiker kebersihan tangan.	☐	☐	☐

Keterangan Hasil Pengamatan *

Jawaban Anda

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut *

Jawaban Anda

Bukti Dokumentasi

1 poin

Upload maksimum 5 file yang didukung. Maks 10 MB per file.

[Tambahkan file](#)

Kembali

Kirim

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

ICRA PROGRAM

a. SKORING ICRA

NO	POTENSIAL RESIKO/ MASALAH	FREKUENSI					DAMPAK YANG DITIMBULKAN					KESIAPAN/SISTEM					Jumlah Skor = Angka kejadian X Dampak x Kesiapan Sistem
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	(Jenis Kelompok Risiko: HAIs, Invasif, Gizi, Lingkungan, dll)																
	(Daftar Risiko/masalah)																
	(Daftar Risiko/masalah)																
	(Daftar Risiko/masalah)																
	(Daftar Risiko/masalah)																
	(Daftar Risiko/masalah)																
	(Daftar Risiko/masalah)																

Keterangan:

FREKUENSI			DAMPAK YANG DITIMBULKAN			KESIAPAN/SISTEM		
1	:	Tidak pernah ada kejadian	1	:	Tidak ada cedera	1	:	Solid
2	:	Jarang (Frekuensi 1-2 x/tahun)	2	:	Cedera ringan	2	:	Good
3	:	Kadang (Frekuensi 3-4 x/tahun)	3	:	Cedera sedang	3	:	Fair
4	:	Agak sering (Frekuensi 4-6 x/tahun)	4	:	Cedera luas/berat	4	:	Poor
5	:	Sering (Frekuensi >6 x/tahun)	5	:	Kematian	5	:	None

b. SKALA PRIORITAS DAN RENCANA TINDAK LANJUT ICRA

NO	JENIS KELOMPOK RISIKO	POTENSIAL RISIKO	SKOR	PRIORITAS	TUJUAN UMUM	TUJUAN KHUSUS	STRATEGI	EVALUASI	PROGRESS/ANALISIS
1	(Jenis Kelompok Risiko: HAIs, Invasif, Gizi, Lingkungan, dll)	(Daftar Risiko/masalah)							
		(Daftar Risiko/masalah)							
		(Daftar Risiko/masalah)							

Lampiran 4

Formulir Elektronik Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan



01. Formulir Hand Hygiene

Formulir yang harus diisi saat melakukan pemantauan kebersihan tangan.

kppirsphmalang@gmail.com [Ganti akun](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Email *

☐ Rekam kppirsphmalang@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

Tanggal Audit *

Masukkan Tanggal hari ini

Tanggal

dd/mm/yyyy

PW *

Jawaban Anda

Nama Auditor *

Pilih

Periode Laporan *

Pilih

Ruangan yang di Audit *

Pilih

Kategori petugas yang diamati/diaudit *

☐ Dokter

☐ Perawat/Bidan

☐ Nakes lain (Apoteker, TTK, Ahli Gizi, Analis, perekam medis)

☐ Non Nakes

Nama petugas yang diamati/diaudit *

Jawaban Anda

Berikutnya

Kosongkan formulir

PENGAMATAN HAND HYGIENE PETUGAS

Isilah berdasarkan hasil pengamatan anda.

Nama Tindakan *

Jawaban Anda

Hasil Pengamatan 5 Momen dan 6 Langkah Cuci Tangan Petugas *

	Ya	Tidak	NA
Sebelum kontak dengan pasien.	☐	☐	☐
Sebelum melakukan tindakan aseptik.	☐	☐	☐
Setelah terpapar cairan tubuh pasien.	☐	☐	☐
Setelah kontak dengan pasien.	☐	☐	☐
Setelah kontak dengan lingkungan pasien.	☐	☐	☐
Melakukan 6 langkah cuci tangan.	☐	☐	☐

Keterangan Hasil Pengamatan *

Jawaban Anda

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut *

Jawaban Anda

Kembali

Kirim

Kosongkan formulir

Lampiran 5

Formulir Elektronik Audit Bundle ISK

IRNA 2C Audit Bundle

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

80%

A1

NO

1	NO	TANGGAL	PERIODE BULAN	NAMA RUANG	NAMA PASIEN	DIAGNOSA	Pemasangan sesuai indikasi	Pemasangan menggunakan alat steril	Hand Hygiene	Penggunaan APD	Segera dilepas jika tidak indikasi	Pengisian balon sesuai (30 ml)	Fiksasi kateter dengan plester	Urine bag menggantung	TAHUN	NILAI	Prosentase
424																0	0.00%
425																0	0.00%
426																0	0.00%
427																0	0.00%
428																0	0.00%
429																0	0.00%
430																0	0.00%
431																0	0.00%
432																0	0.00%
433																0	0.00%
434																0	0.00%
435																0	0.00%
436																0	0.00%
437																0	0.00%
438																0	0.00%
439																0	0.00%
440																0	0.00%
441																0	0.00%
442																0	0.00%
443																0	0.00%
444																0	0.00%
445																0	0.00%
446																0	0.00%
447																0	0.00%
448																0	0.00%

BUNDLE PHLEBITIS

BUNDLE ISK

IDO (PRE-POST)

BUNDLE IADP

BUNDLE VAP

Form Elektronik Audit Bundle Phlebitis

IRNA 2C Audit Bundle

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

75%

A1

NO

1	NO	TANGGAL	PERIODE BULAN	NAMA RUANG	NAMA PASIEN	DIAGNOSA	Hand hygiene	Menggunakan APD sesuai	Pemasangan dengan teknik aseptik	Lokasi pemasangan sesuai/tepat	Disinfeksi Kulit dengan alkohol 70%	Teknik aseptik saat injeksi/sambungan tubing	Kondisi dressing baik (bersih, fiksasi baik)	Tidak menggunakan antibiotik lebih dari 1	Segera dilepas jika sudah tidak ada indikasi pemasangan	Diganti setelah 3 hari pemasangan	Tahun	Nilai	Prosentase
428																			
429																			
430																			
431																			
432																			
433																			
434																			
435																			
436																			
437																			
438																			
439																			
440																			
441																			
442																			
443																			
444																			
445																			
446																			
447																			
448																			
449																			
450																			
451																			
452																			
453																			

BUNDLE PHLEBITIS

BUNDLE ISK

IDO (PRE-POST)

BUNDLE IADP

BUNDLE VAP

Form Elektronik Audit Bundle VAP

IRNA 2C Audit Bundle

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

100%

A1

NO

1	NO	TANGGAL	PERIODE BULAN	NAMA RUANG	NAMA PASIEN	DIAGNOSA	Head Of Bed >30°-45°	Pengkajian setiap hari terhadap sedasi dan extubasi	Hand hygiene	Oral Hygiene 4 – 6 jam	Suction / manajemen sekresi	Profilaksis	Tahun	Nilai	Prosentase
2	1													0	0.00%
3	2													0	0.00%
4	3													0	0.00%
5	4													0	0.00%
6	5													0	0.00%
7	6													0	0.00%
8	7													0	0.00%
9	8													0	0.00%
10	9													0	0.00%
11	10													0	0.00%
12	11													0	0.00%
13	12													0	0.00%
14	13													0	0.00%
15	14													0	0.00%
16	15													0	0.00%
17	16													0	0.00%
18	17													0	0.00%

BUNDLE PHLEBITIS

BUNDLE ISK

IDO (PRE-POST)

BUNDLE IADP

BUNDLE VAP

[illegible]

IKO Audit Bundle IDO (Intra Op) ☆ 📁 ☰

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

🔍 ↶ ↷ 🖨️ 🗑️ 90% ▾ \$ % ⬇️ ⬆️ .00 123 Arial ▾ - [10] + B I U A [color picker] [background color picker] [font size] [bold] [italic] [underline] [link] [unlink] [text color] [background color] [list] [indent] [outdent] [undo] [redo] [find] [replace] [sum]

G2178 ▾ 🏠 YA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	NO	TANGGAL	PERIODE BULAN	NAMA RUANG	NAMA PASIEN	DIAGNOSA	Surgical Hand Hygiene	Instrumen yang dipakai steril	Desinfeksi area operasi	Minimal jumlah tim operasi	Lingkungan kamar operasi bersih	Suhu & kelembapan kamar operasi baik	Tahun	Nilai	Prosentase
2192	2191			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2193	2192			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2194	2193			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2195	2194			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2196	2195			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2197	2196			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2198	2197			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2199	2198			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2200	2199			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2201	2200			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2202	2201			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2203	2202			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2204	2203			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2205	2204			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2206	2205			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2207	2206			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2208	2207			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2209	2208			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			
2210	2209			▾			▾	▾	▾	▾	▾	▾			

+ ≡ IDO (INTRA) ▾

IRNA 2C Audit Bundle

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

75% Arial - 10 B I A

A1 NO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	NO	TANGGAL	PERIODE BULAN	NAMA RUANG	NAMA PASIEN	DIAGNOSA	Mandi air sabun sebelum operasi	Hindari pencukuran/C-ukur E-clippers/cut clipper	Temperatur Tubuh Normal	AB Profilaksis 1 Jam Sebelum Insisi	Px Tidak Sedang Infeksi	GO Terkontrol	Hand Hygiene sebelum tindakan	Luka Tertutup 24-48 jam (kecuali ada rembesan)	Nutrisi sesuai	Motivasi, Edukasi Perawatan Pasca Op	Tahun	N101	Prosentase
428	427																		
429	438																		
430	439																		
431	430																		
432	431																		
433	432																		
434	433																		
435	434																		
436	435																		
437	436																		
438	437																		
439	438																		
440	439																		
441	440																		
442	441																		
443	442																		
444	443																		
445	444																		
446	445																		
447	446																		
448	447																		
449	448																		
450	449																		

+ BUNDLE PHLEBITIS BUNDLE ISK IDO (PRE-POST) BUNDLE IADP BUNDLE VAP

Lampiran 6
Formulir Elektronik Logbook IPCLN

Maternitas Log Book													
File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan													
Menu 90% 123 Default... 9 B I A													
A1 Tanggal													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Tanggal	Input surveilans & audit PPI di SIMRS & Link PPI.	Temuan & Tindak Lanjut	Memotivasi dan mengingatkan petugas lainnya terhadap Hand hygiene, APD, Etika batuk dan kepatuhan PPI lainnya.	Temuan & Tindak Lanjut	Memonitor kepatuhan petugas kesehatan lain dalam penerapan kewaspadaan isolasi (kewaspadaan standart & transmisi).	Temuan & Tindak Lanjut	Lapor IPCN jika terjadi kecurigaan HAI's.	Temuan & Tindak Lanjut	Memberikan edukasi terhadap pasien, keluarga, & pengunjung, terkait PPI berkoordinasi dengan IPCN dan petugas unit terkait.	Temuan & Tindak Lanjut	Memantau pelaksanaan edukasi bagi pasien, keluarga dan pengunjung terkait dengan PPI.	Temuan & Tindak Lanjut
309			simrs error.		MENGGUNAKAN APD SESUAI				HAIs		Px cuci tangan dengan handrub.		RM belum di TTD pasien
310	02/01/2025	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	BIDAN MATERNITAS MENGGUNAKAN APD SESUAI	✓	-	✓	Tidak ada kejadian HAIs	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Bukti edukasi RM belum di TTD pasien
311	03/01/2025	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	BIDAN MATERNITAS MENGGUNAKAN APD SESUAI	✓	-	✓	Tidak ada kejadian HAIs	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Bukti edukasi RM belum di TTD pasien
312	04/01/2025	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	BIDAN MATERNITAS MENGGUNAKAN APD SESUAI	✓	-	✓	Tidak ada kejadian HAIs	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Bukti edukasi RM belum di TTD pasien
313	05/01/2025	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	BIDAN MATERNITAS MENGGUNAKAN APD SESUAI	✓	-	✓	Tidak ada kejadian HAIs	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Bukti edukasi RM belum di TTD pasien
314	06/01/2025	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	BIDAN MATERNITAS MENGGUNAKAN APD SESUAI	✓	-	✓	Tidak ada kejadian HAIs	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Bukti edukasi RM belum di TTD pasien
315	07/01/2025	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	BIDAN MATERNITAS MENGGUNAKAN APD SESUAI	✓	-	✓	Tidak ada kejadian HAIs	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Bukti edukasi RM belum di TTD pasien
316	08/01/2025	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	BIDAN MATERNITAS MENGGUNAKAN APD SESUAI	✓	-	✓	Tidak ada kejadian HAIs	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Bukti edukasi RM belum di TTD pasien
317	09/01/2025	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	BIDAN MATERNITAS MENGGUNAKAN APD SESUAI	✓	-	✓	Tidak ada kejadian HAIs	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Bukti edukasi RM belum di TTD pasien
318	10/01/2025	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	BIDAN MATERNITAS MENGGUNAKAN APD SESUAI	✓	-	✓	Tidak ada kejadian HAIs	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Bukti edukasi RM belum di TTD pasien
319	11/01/2025	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	BIDAN MATERNITAS MENGGUNAKAN APD SESUAI	✓	-	✓	Tidak ada kejadian HAIs	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Bukti edukasi RM belum di TTD pasien

Gizi Log Book													
File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan													
Menu													
A1													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Tanggal	Input surveillance & audit PPI di SIMRS & Link PPI	Temuan & Tindak Lanjut	Memotivasi dan mengingatkan petugas lainnya terhadap Hand hygiene, APD, Etika batuk serta memonitor kepatuhan petugas kesehatan lain dalam penerapan kewaspadaan isolasi (kewaspadaan standar & transmisi).	Temuan & Tindak Lanjut	Memonitor kepatuhan petugas pantry dalam melakukan pencucian alat makan & dapur. (Pemakaian APD, HH, teknik aseptik, penggunaan air panas)	Temuan & Tindak Lanjut	Lapor IPCN jika ditemukan benda asing dalam makanan.	Temuan & Tindak Lanjut	Memberikan edukasi terhadap pasien, keluarga, & pengunjung terkait PPI berkoordinasi dengan IPCN dan petugas unit terkait.	Temuan & Tindak Lanjut	Melakukan pemantauan terhadap pelayanan makanan mulai dari penerimaan bahan s.d pendistribusian makanan.	Temuan & Tindak Lanjut
2	Contoh Pengisian (01/01/2024)	✓	Terlambat input karena simrs error.	✓	penyaji A tidak memakai masker dengan benar.	✓	CS X tidak memakai air panas untuk mencuci alat makan.	✗	Tidak ada benda asing di makanan.	✓	Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Barang datang di ruang penerimaan belum di tata (berantakan)
3	08/03/2024	✓	Audit kepatuhan APD & audit HH di Gdrive.	✓	Petugas penjamah makanan patuh terhadap penggunaan APD.	✓	Semua petugas patuh terhadap prinsip PPI saat mencuci alat makan & dapur.	✓	Tidak ada benda asing di makanan.	✓	Mengajarkan anggota unit cuci tangan yg benar dengan handrub dan juga handwash saat pergantian shift. Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Semua petugas patuh terhadap pelayanan makanan.
4	09/03/2024	✓	Audit kepatuhan APD & audit HH di Gdrive.	✓	Petugas penjamah makanan patuh terhadap penggunaan APD.	✓	Semua petugas patuh terhadap prinsip PPI saat mencuci alat makan & dapur.	✓	Tidak ada benda asing di makanan.	✓	Mengajarkan anggota unit cuci tangan yg benar dengan handrub dan juga handwash saat pergantian shift. Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Semua petugas patuh terhadap pelayanan makanan.
5	10/03/2024	✓	Audit kepatuhan APD & audit HH di Gdrive.	✓	Petugas penjamah makanan patuh terhadap penggunaan APD.	✓	Semua petugas patuh terhadap prinsip PPI saat mencuci alat makan & dapur.	✓	Tidak ada benda asing di makanan.	✓	Mengajarkan anggota unit cuci tangan yg benar dengan handrub dan juga handwash saat pergantian shift. Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Semua petugas patuh terhadap pelayanan makanan.
6	12/03/2024	✓	Audit kepatuhan APD & audit HH di Gdrive.	✓	Petugas penjamah makanan patuh terhadap penggunaan APD.	✓	Semua petugas patuh terhadap prinsip PPI saat mencuci alat makan & dapur.	✓	Tidak ada benda asing di makanan.	✓	Mengajarkan anggota unit cuci tangan yg benar dengan handrub dan juga handwash saat pergantian shift. Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Ditemukan Tirai PVC di dekat ruang penerimaan bahan makanan disingkap ke rak stainless disampingnya.
7	13/03/2024	✓	Audit kepatuhan APD & audit HH di Gdrive.	✓	Petugas penjamah makanan patuh terhadap penggunaan APD.	✓	Semua petugas patuh terhadap prinsip PPI saat mencuci alat makan & dapur.	✓	Tidak ada benda asing di makanan.	✓	Mengajarkan anggota unit cuci tangan yg benar dengan handrub dan juga handwash saat pergantian shift. Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Semua petugas patuh terhadap pelayanan makanan.
	14/03/2024	✓	Audit kepatuhan APD & audit HH di Gdrive.	✓	Petugas penjamah makanan patuh terhadap penggunaan APD.	✓	Semua petugas patuh terhadap prinsip PPI saat mencuci alat makan & dapur.	✓	Tidak ada benda asing di makanan.	✓	Mengajarkan anggota unit cuci tangan yg benar dengan handrub dan juga handwash saat pergantian shift. Mengajarkan keluarga Px cuci tangan dengan handrub.	✓	Semua petugas patuh terhadap pelayanan makanan.

Lampiran 7
Formulir Elektronik Logbook IPCN

JADWAL SPV & LOG BOOK IPCN 2024 dst

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

80% 123 Calibri 11 B I A

Bagikan

A1	Tanggal	Kegiatan	Facilitas HH	Ketersediaan APD	Linen	Ungkungan	Ambulans	TPS B3	Penanganan Sampah	Limbah Benda Tajam	Penyuntikan aman & Tek. Aseptik	Sterilisasi & BMHP	Penanganan Specimen	Penanganan Tumpahan Infeksius	Penyimpanan & transportasi vaksin	Etika Batuk	Immuno	Penempatan TB	Transfer px TB IGD	Pengolahan Makanan	K. Jenazah	HH	Phlebits
1	03/01/2025	-Mengerjakan Laporan TW 4 Kesling -Mengerjakan Laporan SMT 2 Lingkungan -Melakukan monitoring pengisian surveilans di SIMRS -Melakukan monitoring bundle HAIs																					
2	04/01/2025	-Menginput laporan SIMAR -Menginput laporan TW 4 Kesling -Menginput laporan SMT 2 lingkungan SIPELITA (belum berhasil) -Mengerjakan Laporan Bulanan PPI -Mengerjakan Laporan Tahunan PPI -Melakukan monitoring pengisian surveilans di SIMRS																					
3	06/01/2025	-Mengerjakan Laporan Bulanan PPI -Mengerjakan Laporan Tahunan PPI -Melakukan monitoring pengisian surveilans di SIMRS -Melakukan monitoring bundle HAIs																					
4	06/01/2025	Farmasi																					
5	06/01/2025	Gizi																					
6	06/01/2025	Kamar Jenazah																					
7	06/01/2025	IRINA BA																					
8	06/01/2025	IRINA 6A																					
9	06/01/2025	IRINA 7A																					
10	06/01/2025	IRINA 5C																					
11	07/01/2025	-Melakukan monitoring pengisian surveilans di SIMRS -Melakukan monitoring bundle HAIs																					
12	07/01/2025	TPS B3																					
13	07/01/2025	Laundry																					
14	07/01/2025	CSSD																					
15	07/01/2025	Kamar Jenazah																					
16	07/01/2025																						
17	07/01/2025																						

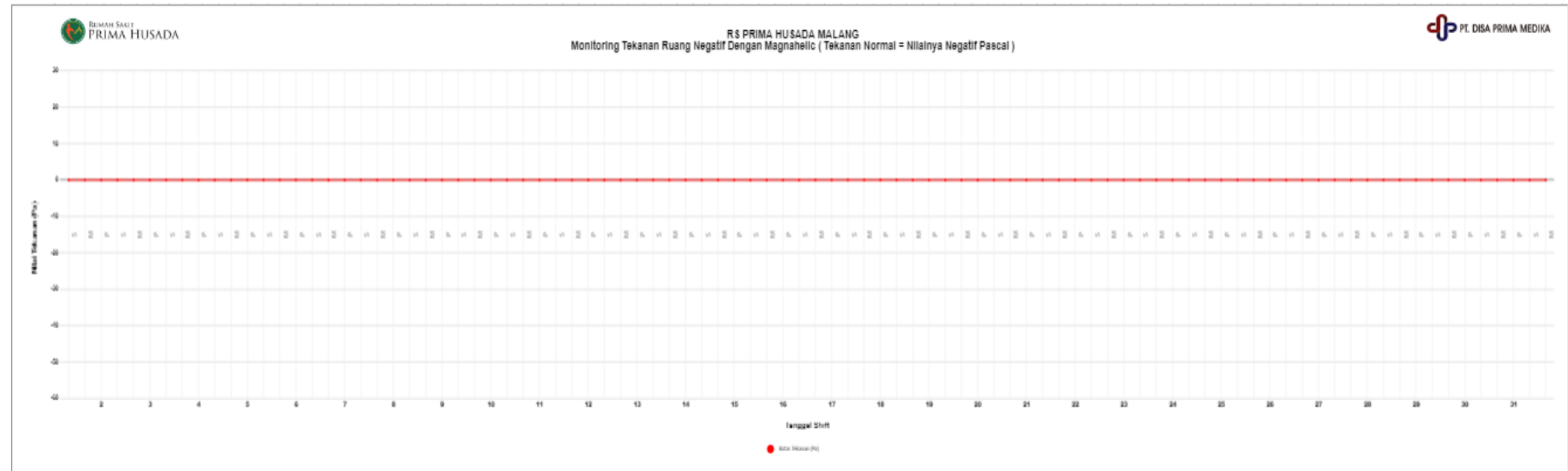
[illegible]

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
Monitoring Tekanan Ruang Negatif Dengan Magnahello (Tekanan Normal = Nilainya Negatif Paoal)



Kat :	1. Isi dengan angka yang sesuai pada kolom tekanan (Pa) sebagai tanda ukuran tekanan pada tanggal tersebut, grafik secara otomatis akan terbentuk.	(---) Tekanan ruangan tidak lebih dari 0 pascal
	2. Tuliskan inisial staf yang melakukan pencatatan dan akan di supervisi (v) oleh kepala ruang setiap harinya.	



Lampiran 10



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
Monitoring Tekanan Ruang Positif Dengan Magnahello (Tekanan Normal = Nilainya Positif Pascal)



BULAN :
TEMPAT :

TANGGAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	P	8	M	P	8	M	P	8	M	P	8	M	P	8	M	P	8	M	P	8	M	P	8	M	P	8	M	P	8	M	P	8
Batas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekanan																																
Inisial Staff																																
Supervisi Karu																																

Ket :

1. Isi dengan angka yang sesuai pada kolom tekanan (Pa) sebagai tanda ukuran tekanan pada tanggal tersebut, grafik secara otomatis akan terbentuk.

2. Tuliskan inisial staf yang melakukan pencatatan dan akan di supervisi (v) oleh kepala ruang setiap harinya.

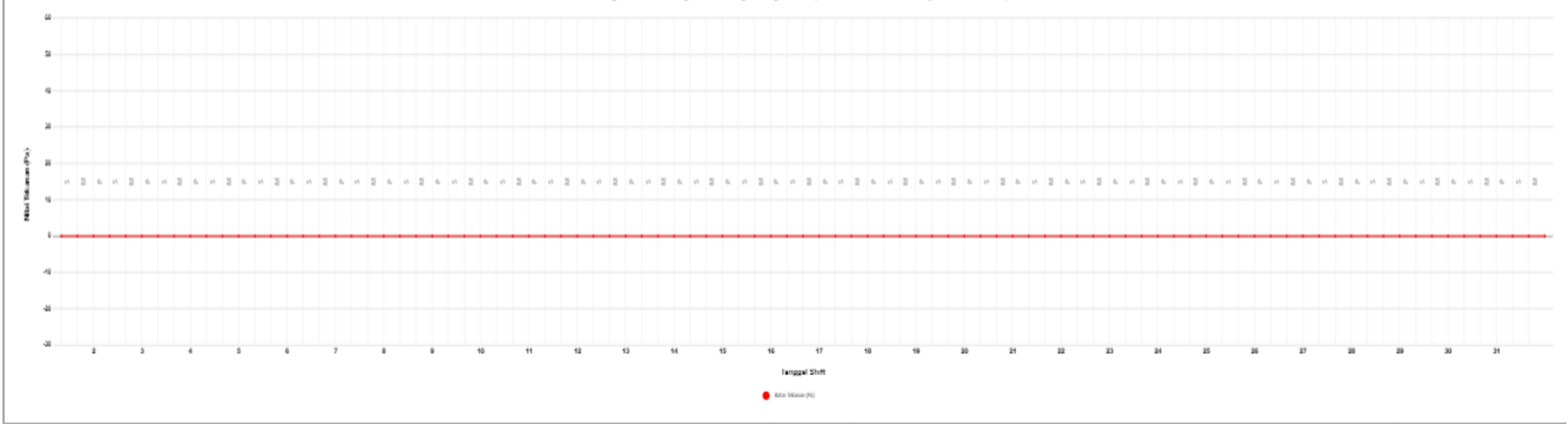
(---) Tekanan ruangan tidak kurang dari 0 pascal



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RS PRIMA HUSADA MALANG
Monitoring Tekanan Ruang Positif Dengan Magnahello (Tekanan Normal = Nilainya Positif Pascal)





31

Lampiran 12
Formulir Elektronik Pelaporan Phlebitis



04 Formulir Pelaporan Phlebitis

Formulir yang harus diisi saat menemukan/menjumpai pasien yang phlebitis < 3x24 jam dengan pemasangan oleh petugas RS Prima Husada Malang.

kppirsphmalang@gmail.com [Ganti akun](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Email *

☐ Rekam kppirsphmalang@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

Tanggal Lapor *

Tanggal

dd/mm/yyyy

PW *

Jawaban Anda

Periode Laporan *

Pilih

Nama Pasien *

(Gunakan huruf kapital, Contoh: NY GITI / TN JONO / AN BANU / NN EMI / SDR UMAR)

Jawaban Anda

No RM Pasien *

Jawaban Anda

Unit *

Pilih

Usia Pasien *

(Contoh: 15 TH atau 2 HR atau 7 BLN)

Jawaban Anda

Diagnosa Pasien *

(Gunakan huruf kapital)

Jawaban Anda

Tanggal Awal Pasang Infus *

Tanggal

dd/mm/yyyy

Tanggal Phlebitis *

Tanggal

dd/mm/yyyy

Skor Phlebitis *

Pilih

Penggunaan Obat Pekat/Anti Biotik lebih dari 1 macam *

Jawaban Anda

Petugas pemasang infus yang phlebitis? *

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google

Formulir

34

Lampiran 13
Formulir Elektronik Pelaporan IDO

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		FORMULIR PENGUMPULAN DATA INFEKSI DAERAH OPERASI		 PT. DISA PRIMA MEDIKA	
Nama Pasien : ...		No RM : ...		Unit Pelapor: ...	
Tanggal Laporan: ... / ... / ...		Lama Operasi: ... Menit		Operasi Karena Trauma: ...	
Tanggal Operasi: ... / ... / ...		Jenis Operasi: ...		Ruang Operasi: ...	
Berat Badan: ... Kg		Usia Pasien: ...		Kualifikasi Dokter Bedah: ...	
Suhu Pasien: ☐ $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ☐ $< 38^{\circ}\text{C}$		Hb: ...		Leukosit: ...	
Merokok? ☐ Ya ☐ Tidak		Gula Darah: ☐ $> 200 \text{ mg/dl}$ ☐ $\leq 200 \text{ mg/dl}$		Steroid Jangka Panjang: ...	
Pencukuran: ...		Mandi Sebelum Operasi: (Max. 1x24 jam pre-op)		Profilaksis: ...	
Suhu Ruang OK: ... $^{\circ}\text{C}$		Kelembapan Ruang OK: ... %		Drain: ...	
Tekanan Udara: ☐ Positif ☐ Negatif		Jamur AC: ...		Implant: ...	
Post Op Hari Ke-: ...		Rwt Luka: ...		Dressing: ...	
Nutrisi: ...		Atf drain: ...		Angkat Jahitan: ...	
Konsumsi AB: ...		KRS: ...		Kontrol Poli: ...	
Identifikasi IDO: ...		Nyeri lokal dan sakit: ...		Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$): ...	
Kemerahan: ...		Drainase purulen/pus: ...		Bengkak terlokalisir: ...	
Kuman pada kultur pus: ...		Ada abses saat re-operasi/pemeriksaan radiologi/PA: ...		Diagnosis Dokter: IDO: ...	
BILA TERJADI INFEKSI, Beri tanda ceklist 'v' pada kotak yang sesuai.		Jenis Lokasi Infeksi: ...		Lokasi Spesifik Untuk Infeksi Organ / Rongga: ...	

KETERANGAN PENGISIAN FORMULIR:

- 1 Kolom PRE OPERASI diisi oleh perawat ruangan/IGD.
- 2 Kolom DURANTE OPERASI diisi oleh perawat IKO
- 3 Kolom POST OPERASI diisi oleh perawat ruangan/ICU. Jika px dilanjutkan kontrol ke Poli, dilanjutkan diisi oleh perawat Poli.
- 4 Bila Pasien pulang, formulir ini dikumpulkan pada ICLN (Infection Control Link Nurse) di masing-masing unit, dan diserahkan pada IPCN.

Pengisian Definisi Tingkat Kontaminasi Daerah Operasi:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Bersih : Luka operasi tidak infeksi, tidak ada inflamasi dan tidak membuka traktus respiratorius/orofaring, traktus gastrointestinal/biliar, traktus genitourinarius dimana kasus luka operasi ini ditutup secara primer serta sistem drainase tertutup. | 3 | Terkontaminasi : Luka operasi yang membuka semua sistem traktus kecuali ovarium dan nyata terjadi pencemaran (perforasi) baru dan luka trauma dan insisi yang akut < 6 jam - inflamasi non purulen. |
| 2 | Bersih Terkontaminasi : Luka operasi yang memasuki / membuka traktus respiratorius, pencernaan/biliar, appendix, vagina dan orofaring. | 4 | Luka kotor : Luka traumatik > 6 jam dengan hilangnya jaringan dan tampak infeksi atau perforasi viseral. |

Ref : Guideline Preventing SSI(2009)/www.cdc.gov, SSI Event(2011)/www.cdc.gov

Lampiran 14
Formulir Elektronik Pelaporan Decubitus



06 Formulir Pelaporan Decubitus

Formulir yang harus diisi saat menemukan/menjumpai pasien yang mengalami decubitus setelah tirah baring > 3x24 jam.

kppirsphmalang@gmail.com [Ganti akun](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi.

Email *

☐ Rekam kppirsphmalang@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

Tanggal Lapor *

Tanggal

dd/mm/yyyy

PW *

Jawaban Anda

Periode Laporan *

Pilih

Nama Pasien *

(Gunakan huruf kapital, Contoh: NY GITI / TN JONO / AN BANU / NN EMI / SDR UMAR)

Jawaban Anda

No RM Pasien *

Jawaban Anda

Unit *

Pilih

Usia Pasien *

(Contoh: 15 TH atau 2 HR atau 7 BLN)

Jawaban Anda

Jawaban Anda

Pilih dd/mm/yyyy

C

Jawaban Anda

Jawaban Anda

Lampiran 15
Formulir Elektronik Pelaporan ISK



07 Formulir Pelaporan ISK

Formulir yang harus diisi saat menemukan/menjumpai pasien yang mengalami ISK > 3x24 jam dengan pemasangan oleh petugas RS Prima Husada Malang.

kppirsphmalang@gmail.com [Ganti akun](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Email *

☐ Rekam kppirsphmalang@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

Tanggal Laporan *

Tanggal

dd/mm/yyyy

PW *

Jawaban Anda

Periode Laporan *

Pilih

Nama Pasien *

(Gunakan huruf kapital, Contoh: NY GITI / TN JONO / AN BANU / NN EMI / SDR UMAR)

Jawaban Anda

No RM Pasien *

Jawaban Anda

Unit *

Pilih

Usia Pasien *

(Contoh: 15 TH atau 2 HR atau 7 BLN)

Jawaban Anda

Diagnosa Pasien *

(Gunakan huruf kapital)

Jawaban Anda

Tanggal Awal Pasang Kateter *

Tanggal

dd/mm/yyyy

Tanggal terjadi ISK *

Tanggal

dd/mm/yyyy

Keterangan *

Jawaban Anda

Petugas yang melaporkan *

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Lampiran 16
Formulir Elektronik Pelaporan VAP



08 Formulir Pelaporan VAP

Formulir yang harus diisi saat menemukan/menjumpai pasien yang mengalami VAP > 3x24 jam dengan pemasangan oleh petugas RS Prima Husada Malang.

kppirsphmalang@gmail.com [Ganti akun](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Email *

☐ Rekam kppirsphmalang@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

Tanggal Lapor *

Tanggal

dd/mm/yyyy

PW *

Jawaban Anda

Periode Laporan *

Pilih

Nama Pasien *

(Gunakan huruf kapital, Contoh: NY GITI / TN JONO / AN BANU / NN EMI / SDR UMAR)

Jawaban Anda

No RM Pasien *

Jawaban Anda

Unit *

Pilih

Usia Pasien *

(Contoh: 15 TH atau 2 HR atau 7 BLN)

Jawaban Anda

Diagnosa Pasien *

(Gunakan huruf kapital)

Jawaban Anda

Tanggal Awal Ventilator *

Tanggal

dd/mm/yyyy 

Tanggal terjadi VAP *

Tanggal

dd/mm/yyyy 

Keterangan *

(Lampirkan hasil penunjang diagnosa VAP, contohnya: Leukositosis, FiO2 <250%, penurunan kesadaran, sekret berlebih di saluran nafas, hasil foto serial > 2x dengan hasil pneumonia, ada demam, dll)

Jawaban Anda

Petugas yang melaporkan *

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir

Lampiran 17
Formulir Elektronik Pelaporan IADP



09 Formulir Pelaporan IADP

Formulir yang harus diisi saat menemukan/menjumpai pasien yang mengalami IADP > 3x24 jam dengan pemasangan CVC oleh petugas RS Prima Husada Malang.

kppirsphmalang@gmail.com [Ganti akun](#)

** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi*

Email *

☐ Rekam kppirsphmalang@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

Tanggal Lapor *

Tanggal

dd/mm/yyyy 

PW *

Jawaban Anda

Periode Laporan *

Pilih

Nama Pasien *

(Gunakan huruf kapital, Contoh: NY GITI / TN JONO / AN BANU / NN EMI / SDR UMAR)

Jawaban Anda

No RM Pasien *

Jawaban Anda

Unit *

Pilih

Usia Pasien *

(Contoh: 15 TH atau 2 HR atau 7 BLN)

Jawaban Anda

Diagnosa Pasien *

(Gunakan huruf kapital)

Jawaban Anda

Tanggal Awal pasang CVC *

Tanggal

dd/mm/yyyy

Tanggal terjadi IADP *

Tanggal

dd/mm/yyyy

Keterangan *

Jawaban Anda

Petugas yang melaporkan *

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Lampiran 18
 Formulir Elektronik Pelaporan Tumpahan Infeksius

									
FORM PELAPORAN TUMPAHAN INFEKSIUS RS PRIMA HUSADA									
Bulan/Tahun :									
Tgl	Jenis Tumpahan Infeksius				Penggunaan Spill Kit		Nama Unit	Keterangan	Nama Petugas
	Darah	Muntahan	Air Kencing	Cairan Tubuh Lainnya	Ya	Tidak			
Contoh	☒	☐	☐	☐	☒	☐	IRNA 8A	Tetes darah didekat bed pasien Dahlia 2-3, isi spill kit sudah dilengkapi kembali.	Rino
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
TOTAL	0	0	0	0	0	0			
Mengetahui, IPCN :									
TTD KARU CS :									
(.....)									
(.....)									

Lampiran 19

Web Komite PPI RS Prima Husada (wadah link pelaporan dan kegiatan-kegiatan Komite PPI RS Prima Husada: <https://sites.google.com/view/komite-ppi-rs-prima-husada/home>)



Ijin Kerja Dari Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Izin no:					
Lokasi kontruksi:			Tanggal mulai proyek:		
Koordinator proyek:			Perkiraan durasi:		
Pekerjaan kontruksi:			Tanggal Kadaluarsa:		
Supervisor:			Telephone:		
Ya	Tidak	Aktifitas Kontruksi	Ya	Tidak	Kelompok Berisiko
		Tipe A: Inspeksi, aktifitas non invasif			Kelompok 1: Risiko rendah
		Tipe B: Skala kecil, durasi pendek, tingkat sedang-tinggi			Kelompok 2: Risiko sedang
		Tipe C: Kegiatan yang menghasilkan debu tingkat sedang sampai tinggi, membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 1 shift.			Kelompok 3: Risiko tinggi
		Tipe D: Kegiatan kontruksi level tinggi. Membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang.			Kelompok 4: Risiko sangat tinggi
Kelas I		3. Pembongkaran minor untuk perombakan ulang.			
Tgl.					
Paraf					
Kelas II		6. Letakkan limbah kontruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang. 7. Lakukan pengepelan basah dan/atau vakum dengan HEPA filter sebelum meninggalkan area kerja. 8. Letakkan dust mat (keset debu) di pintu masuk dan keluar area kerja. 9. Isolasi sistem HVAC di daerah di mana pekerjaan sedang dilakukan, rapikan kembali setelah pekerjaan selesai.			
Tgl.					
Paraf					
Kelas III		6. Vakum area kerja dengan penyaring HEPA. 7. Lakukan pengepelan basah dengan pembersih/disinfektan. 8. Lakukan pembongkaran bahan-bahan pembatas area kerja dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan puing-puing konstruksi. 9. Letakkan limbah kontruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang. 10. Tutup wadah atau gerobak transportasi limbah. 11. Setelah pekerjaan selesai,			
Tgl.					
Paraf					

	menggunakan unit penyaringan udara HEPA. 5. Pembatas area kerja harus tetap dipasang sampai proyek selesai diperiksa oleh Komite K3, KPPI, dan dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan.	rapikan kembali sistem HVAC.
Kelas IV Tgl. Paraf	1. Memperoleh perizinan dari KPPI sebelum kegiatan konstruksi dimulai. 2. Mengisolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi sistem saluran. 3. Siapkan pembatas area kerja atau terapkan metode kontrol kubus (menutup area kerja dengan plastik dan menyegel dengan vakum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum konstruksi dimulai. 4. Menjaga tekanan udara negatif dalam tempat kerja dengan menggunakan unit penyaringan udara HEPA. 5. Menyegel lubang, pipa, dan saluran. 6. Membuat anteroom dan mewajibkan semua personel untuk melewati ruangan ini sehingga mereka dapat disedot menggunakan vacuum cleaner HEPA sebelum meninggalkan tempat kerja atau mereka bisa memakai pakaian kerja yang lepas setiap kali mereka meninggalkan tempat kerja.	7. Semua personil yang memasuki area kerja diwajibkan untuk memakai penutup sepatu. Sepatu harus diganti setiap kali keluar dari area kerja. Pembatas area kerja harus tetap dipasang sampai proyek selesai diperiksa oleh Komite K3, KPPI, dan dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan. 8. Vakum area kerja dengan penyaring HEPA. 9. Lakukan pengepelan basah dengan pembersih/disinfektan. 10. Lakukan pembongkaran bahan-bahan pembatas area kerja dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan puing-puing konstruksi. 11. Letakkan limbah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang. 12. Tutup wadah atau gerobak transportasi limbah. 13. Setelah pekerjaan selesai, rapikan kembali sistem HVAC.
Persyaratan tambahan:		

Malang,			
Pemberian Ijin PPI:	Koordinator Proyek:	Ketua K3RS:	Kepala Unit IPSRS:



- 1 Nama Proyek
- 2 Arsitek/Kepala Proyek
- 3 Lokasi Proyek
- 4 Kontraktor
- 5 Tanggal

No	Kriteria Risiko	Ya	Tidak	Penjelasan
1.	Apakah konstruksi secara langsung akan mempengaruhi area perawatan pasien?			
2.	Apakah area konstruksi mengandung bahaya lingkungan?			
	Asbestos			
	Bahan kimia			
	Lainnya			
3.	Kualitas Udara			
	A. Apakah indak asupan udara luar telah dipertimbangkan?			
	B. Akankah indak HVAC perlu diseimbangkan kembali sebelum konstruksi untuk memastikan kebutuhan arus udara propser?			
4.	Apakah Manajemen utilitas di bawah ini diperlukan?			
	Sistem deteksi kebakaran			
	Sprinkler			
	Listrik			
	HVAC			
	Air Panas/dingin			
	Sanitasi			
	Uap			
	Lainnya			
5.	Apakah kegiatan konstruksi akan mengakibatkan gangguan kebisingan?			
6.	Apakah kegiatan konstruksi akan mengakibatkan gangguan getaran?			
7.	Apakah pengiriman kontraktor atau pembuangan puing-puing dilakukan di luar jam kerja normal?			
8.	Apakah untuk menghilangkan puing-puing sisa akan membutuhkan lebih dari sekedar indakan pencegahan standar (pengangkatan di gerobak tertutup yang dilepas dengan desinfektan)?			

Direktur RS Prima Husada

Ketua K3RS

(

)

(

)



Formulir Pemantauan Selama Renovasi/Konstruksi Bangunan

Area Renovasi :
Tanggal Pemantauan :

KELAS III/IV

No	Kegiatan	Ya	Tidak	NA	Keterangan
1	Mengisolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi sistem saluran.				
2	Siapkan pembatas area kerja atau terapkan metode kontrol kubus (menutup area kerja dengan plastik dan menyegel dengan vakum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum konstruksi dimulai.				
3	Menjaga tekanan udara negatif dalam tempat kerja dengan menggunakan unit penyaringan udara HEPA.				
4	Letakkan limbah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang.				
5	Tutup wadah atau gerobak transportasi limbah.				
6	Menyegel lubang, pipa, dan saluran.				
7	Membuat anteroom dan mewajibkan semua personel untuk melewati ruangan ini sehingga mereka dapat disedot menggunakan vacuum cleaner HEPA sebelum meninggalkan tempat kerja atau mereka bisa memakai pakaian kerja yang lepas setiap kali mereka meninggalkan tempat kerja.				
8	Semua personil memasuki tempat kerja diwajibkan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD).				

Petugas yang mengobservasi

Koordinator Proyek/Lapangan

(.....)

(.....)



Formulir Pemantauan Selama Renovasi/Konstruksi Bangunan

Area Renovasi :

Tanggal Pemantauan :

KELAS III

No	Kegiatan	Ya	Tidak	NA	Keterangan
1	Mengisolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi sistem saluran.				
2	Siapkan pembatas area kerja atau terapkan metode kontrol kubus (menutup area kerja dengan plastik dan menyegel dengan vakum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum konstruksi dimulai.				
3	Menjaga tekanan udara negatif dalam tempat kerja dengan menggunakan unit penyaringan udara HEPA.				
4	Letakkan limbah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang.				
5	Tutup wadah atau gerobak transportasi limbah.				
6	Menyegel lubang, pipa, dan saluran.				
7	Membuat anteroom dan mewajibkan semua personel untuk melewati ruangan ini sehingga mereka dapat disedot menggunakan vacuum cleaner HEPA sebelum meninggalkan tempat kerja atau mereka bisa memakai pakaian kerja yang lepas setiap kali mereka meninggalkan tempat kerja.				
8	Semua personil memasuki tempat kerja diwajibkan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD).				

Petugas yang mengobservasi

Koordinator Proyek/Lapangan

(.....)

(.....)



CHECKLIST POST KONTRUKSI

Tanggal/Waktu Survey :
Area :
Proyek :

NO	KRITERIA	YA	TIDAK	KETERANGAN
A Penyelesaian Proyek				
1	Pembilasan sistem air utama untuk membersihkan debu pada pipa.			
2	Pembersihan zona konstruksi sebelum memindahkan barrier konstruksi .			
3	Pemeriksaan jamur dan lumut. Bila ditemukan lakukan pembersihan.			
4	Verifikasi parameter ventilasi pada area baru sesuai kebutuhan.			
5	Jangan menerima apabila terdapat kekurangan ventilasi terutama di daerah perawatan khusus.			
6	Bersihkan atau ganti filter HVAC sesuai prosedur penahanan debu yang tepat.			
7	Pindahkan barrier dan bersihkan daerah dari semua debu yang dihasilkan selama pekerjaan / proyek.			
8	Pastikan bahwa keseimbangan tekanan udara di kamar operasi dan lingkungan sekitarnya dapat dicapai sebelum ruangan digunakan.			
9	Kondisi ruang sesuai indikasi terutama di kamar operasi dan lingkungan sekitarnya, pastikan bahwa spesifikasi teknis sesuai yang disyaratkan.			
B Apakah system berikut ini diuji dan berfungsi baik?				
1	Alarm kebakaran – lepaskan penutup detektor & lakukan pengujian dari panel control.			
2	Sprinkler/Penyemprot air - terhubung ke saluran utama dan betekanan cukup.			
3	Listrik – pengujian switch/tombol dan pengontrolan.			
4	Sumber air buka, dan cek suhu.			
5	Gas Medis.			
6	Limbah – hilangkan sumbatan.			
7	HVAC - pemasangan filter, menghilangkan penyumbatan, uji keseimbangan tekanan.			
C Lingkungan				
1	Bersihkan puing-puing, peralatan, perlengkapan, & bahan-bahan bangunan.			
2	Vacuum & bersihkan permukaan di semua area konstruksi untuk menghilangkan debu.			
D Isolation barriers				
1	Pelindung harus di lap basah,			



	disedot dengan hepa, atau diberi uap air sebelum dibongkar.			
2	Pelindung harus dipindahkan dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran & puing-puing.			
E Pengendalian infeksi				
1	Tinjau indikasi untuk melakukan kultur lingkungan dengan satker terkait.			
2	Periksa daerah konstruksi setelah pembersihan akhir dan menyetujui penggunaannya.			
F Keamanan Kebakaran				
1	Tersedianya peralatan pemadam kebakaran.			
G Keselamatan Jiwa				
1	Pintu keluar & rute ke UGD dibuat kembali.			
2	Penempatan tanda pintu keluar dengan tepat.			

Komite PPI/PCN:	Ketua K3RS:	Kepala IPSRS: